Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Isabella Fernanda Arancibia Vilches			Sexo	F		M
Fecha Nacimiento	04/02/2017	Edad actual	9 años	2 meses	País natal:	chilena	
Domicilio actual:	camino internacional			Teléfono	36592099		
Lengua materna		Grado dominio	comprende ☐ habla ☐ lee ☐ escribe ☐				
Lengua de uso		Grado dominio	comprende ☐ habla ☐ lee ☐ escribe ☐				
Escolaridad actual:	2°B	Establecimiento	Liceo Mixto Básica 1				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 29/04/2026.	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Fernanda Vilches	Nombre:
Relación con el/la estudiante: madre	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 29/04/2026.	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Karen Toro	Nombre:
Rol/cargo: Psicopedagoga.	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Diagnostico: • Multideficit.
• No lectora.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☒ Sí (especificar) Lipomielomeningocele

Pediatría:	Psicología: Dra Paulinci.
Kinesiología:	Psiquiatría:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☑ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☐ cesárea (señalar motivo)

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☑ SI ☐ NO | Peso: 3,100 | Talla: 49

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto: Relata la Madre que le inyectaron Penisilina con Anestesia, lo cual Madre e Hija estuvieron en Riesgo de vida, Al nacer Isabella estuvo en la NEO 3 días. Por no tener diagnostico.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	~~No~~	Traumatismos	Sí	~~No~~	Encefalitis	Sí	~~No~~
Obesidad	Sí	~~No~~	Intoxicación	Sí	~~No~~	Meningitis	Sí	~~No~~
Fiebre alta	Sí	~~No~~	Enfermedad respiratoria	Sí	~~No~~	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	~~No~~	Asma	~~Sí~~	No			
Hospitalizaciones	~~Sí~~	No	Especifique motivos y duración: cuando nacio (NEO)					

Se realizaron controles periódicos de salud	Sí	No	Vacunas	Sí	No

Observaciones:
Asma. Padece Hace 4 Año. Budesonida, Salbutamol (SOS)

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a) 10 Meses

Fija la cabeza:	Se sienta sólo/a: 10 meses	Camina sin apoyo: 2 años
Primeras palabras: 11 meses	Primeras frases: 2 años	Se viste solo/a: 2 Años
Controla esfinter vesical Diurno: 2 Año Nocturno: 9 Años	Controla esfinter anal Diurno: 2 Años	Nocturno: 9 Años

Observaciones:
Vejiga neurogenica (observacion)
Trastorno Psicomotor

En su actividad motora general se aprecia: ☑ normal ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo				**Su tono muscular general se aprecia:** ☐ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico				
En relación con su motricidad gruesa se aprecia:								
Estabilidad al caminar	~~Si~~	No	Caídas frecuentes	Sí	~~No~~	Dominancia lateral	~~Si~~	No
En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:								
Garra	~~Si~~	No	Prensión	~~Si~~	No	Pinza		
Ensarta	~~Si~~	No	Dibuja	~~Si~~	No	Escribe	~~Si~~	No
En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)								
Reacciona a voces o caras familiares	~~Si~~	No	Manipula y Explora objetos				~~Si~~	No

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Demanda objetos y compañía	~~Sí~~	No	Comprende prohibiciones	~~Sí~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Sí~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Sí	~~No~~

Observaciones:
sin observaciones

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	~~Sí~~	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	~~Sí~~	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	~~No~~	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	~~Sí~~	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	~~No~~	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	~~Sí~~	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	~~No~~	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	~~No~~
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	~~Sí~~	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	~~Sí~~	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	~~No~~	Presenta frecuentes dolores de oídos	~~Sí~~	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	~~No~~	La pronunciación oral es adecuada	~~Sí~~	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	~~No~~	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	~~No~~

Observaciones: le molesta por ruidos muy fuerte le duele los oidos cuando el ruido es muy fuerte

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☐ oral ☐ gestual ☑ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	~~No~~	Emite/produce frases	~~Sí~~	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	~~No~~	Relata experiencias	~~Sí~~	No
Emite palabras/produce señas	Sí	~~No~~	La emisión/pronunciación/producción es clara	~~Sí~~	No

Características del lenguaje comprensivo

Identifica objetos	~~Sí~~	No	Sigue instrucciones simples	~~Sí~~	No
Identifica personas	~~Sí~~	No	Sigue instrucciones complejas	~~Sí~~	No
Comprende conceptos abstractos	~~Sí~~	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	~~No~~
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	~~Sí~~	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	~~Sí~~	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): Dejo de Hablar despues de la operacion Medula fue 1 Año 2 meses

Observaciones:
sin observaciones

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	~~Sí~~	No	Se relaciona en forma colaborativa	~~Sí~~	No

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Explica razones de sus comportamientos y actitudes	~~Sí~~	No	Respeta normas sociales	~~Sí~~	No
Participa en actividades grupales	Sí	~~No~~	Respeta normas escolares	~~Sí~~	No
Opta por trabajo individual	~~Sí~~	No	Muestra sentido del humor	~~Sí~~	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	~~No~~	Movimientos estereotipados	~~Sí~~	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	~~Sí~~	No	Pataletas frecuentes	Sí	~~No~~

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	**Sonidos:**	**Personas extrañas:**
☑ natural ☐ desmesurada	☑ natural ☐ desmesurada	☐ natural ☑ desmesurada

Observaciones: se descompensa cuando ve personal eltrañas.

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al dia	~~Sí~~	No	Trastorno motor	~~Sí~~	No
Epilepsia	~~Sí~~	No	Problema bronco-respiratorio Asma	~~Sí~~	No
Problemas cardiacos	Sí	~~No~~	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	~~No~~
Paraplejia	Sí	~~No~~	Trastorno emocional	Sí	~~No~~
Pérdida auditiva	Sí	~~No~~	Trastorno conductual	Sí	~~No~~
Pérdida visual	Sí	~~No~~	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique): Epilepsia 2025 11. Mayo. solo un episodio.

Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique) Selectiva.

Peso (apreciación del informante): ☑ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☑ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 8 hora.

☐ insomnio ☑ pesadillas ☑ terrores nocturnos ☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor

Duerme: ☑ solo ☐ acompañado (Especifique):

Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***

☐ alegre ☐ juguetón/bromista ☐ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)
Otro:

Observaciones: Alimentacion selectiva. (Alergia Alimentaria. legumbres)

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Gerado Arancibia	Padre	45	4 Medio	construcción
2. Fernanda Vilches	Madre	31	4 Medio	dueña casa.
3. Nicolai Jofre	Hermano	12	6º	estudiante
4. Isabella Arancibia	Hija	9	2º	Estudiante
5.				
6.				
7.				
8.				

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Antecedentes de Salud de la Familia
(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante): Madre: Artrosis detectada 2024., dislopatia, Hipoplisemia. Abuelos: Diabeticos. Abuelo: Hipertenso.
Observaciones: Sin observaciones

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar												
Edad de ingreso al sistema escolar	3 AÑOS				Asistió a jardín infantil			✓ Sí		No		
N° de colegios en que ha estudiado	3				Modalidad de enseñanza Regular ☑ Especial ☐ Técnica ☐:							
Motivo de los cambios: Escuela el salice Problema con profesora. San jose. Salida tarde												
Ha repetido curso/s	✓ Sí		No		Curso(s) 2°		Motivo: Asistencia y nota.					
Situación actual												
Nivel/curso actual	2°		**Dificultad de aprendizaje**	✓ Sí	No	**Dificultad para participar**	✓ Sí	No	**Conducta disruptiva**	Sí	✓ No	
Asiste regularmente	✓ Sí	No	Asiste con agrado	✓ Sí	No	Apoyo familiar en tareas	✓ Sí	No	Amigos (as)	✓ Sí	No	

Actitud de la familia
¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante? ☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....
¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante? ☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....
¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante? ☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra ..... Especifique el tipo de refuerzos o premios: ☐ expresiones afectivas ☑ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....
¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante? ☑ madre ☑ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....
¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante? ☐ alta (incluye al grupo familiar) ☑ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)
¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje? ☑ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

Requier los Permisos al baño.
- Escritura lenta con Presion.
- lectura baja
- no Reconoce numero dictados.
- confucion de numeros. 13-17. (discalculia)
- Solo Reconoce Minuscula.
- NO Reconoce Vocal (o-a).

Esta pauta –de uso optativo- ha s
recogida de antecedentes de ana
de las NEE

1. DENTIFICACIÓN D

Nombre
Fecha Nacimiento
Domicilio actual:
Lengua materna
Lengua de uso
Escolaridad actual:

2. IDENTIFICACIÓN

1. Fecha de la entrevis
Nombre: Fernan
Relación con el/la estu
En presencia de (mien
3. Fecha de la entrevi
Nombre:
Relación con el/la est
En presencia de (mie

3. IDENTIFICACI

1. Fecha de la entre
Nombre: Marí
Rol/cargo: Ed.
3. Fecha de la entr
Nombre:
Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN

Repeti
Dificul

5. ANTECED

¿El o la estudi
Pediatría:
Kinesiología:
Genético:
Fonoaudiologí
Neurología:

LOS DATOS C